

Czym jest *lęk zdrowotny*?

Nie „hipochondria w starym sensie” — to zaburzenie z mechanizmami, które można zrozumieć i odwrócić.

CZAS: 15 min Do przeczytania na sesji

ŹRÓDŁO: Salkovskis & Warwick (2001); Tyrer (2014); DSM-5-TR (2022)

JAK UŻYWAĆ

Przeczytaj kartę powoli. Zaznacz fragmenty, które brzmią **znajomo**. Na końcu odpowiedz na 3 pytania — to materiał na kolejną sesję. *Nie diagnozuj się sam/-a* — to robota terapeuty.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Pacjenci z lękiem zdrowotnym (ang. *health anxiety*) zazwyczaj słyszą „to tylko nerwy” lub „jesteś hipochondrykiem”. Obie odpowiedzi są błędne i pogłębiają wstyd. **Realne mechanizmy** (Salkovskis 2001): katastroficzna interpretacja, selektywna uwaga, sprawdzanie. Zrozumienie modelu = pierwszy krok do wyjścia z błędnego koła. NNT psychoedukacji jako fundamentu CBT ≈ 3 (Cooper i in., 2017).

01 Definicja — krótko i jasno

Lęk zdrowotny to przewlekłe, nieproporcjonalne zaabsorbowanie chorobą — mimo braku obiektywnych podstaw medycznych. Odczucia cielesne (ból głowy, klucie w klatce, pieprzyk) są **realne**, ale ich *interpretacja* jako oznaki poważnej choroby — przesadna. Dotyczy 1–5% populacji (Tyrer, 2014).

IAD — LĘK BEZ OBJAWÓW

Illness Anxiety Disorder · DSM-5-TR (300.7 / F45.21)

Mocne zaabsorbowanie chorobą, ale objawy fizyczne **minimalne lub nieobecne**. Lęk wzbudza się łatwo, sprawdzanie ciała, googlowanie. Trwa ≥6 mies.

SSD — LĘK Z OBJAWAMI

Somatic Symptom Disorder · DSM-5-TR (300.82 / F45.1)

Realne objawy fizyczne (ból, zmęczenie) + **nadmierne** myśli, uczucia, zachowania wokół nich. Cierpienie wyraźnie ponadprzeciętne.

02 5 mechanizmów podtrzymujących (model Salkovskisa)

1 · KATASTROFICZNA INTERPRETACJA

„Ten ból głowy = guz mózgu”. Normalne odczucie ciała czytane jako sygnał choroby zagrażającej życiu.

2 · SELEKTYWNA UWAGA

Skanowanie ciała w poszukiwaniu „nieprawidłowości”. Im uważniej szukasz, tym więcej znajdziesz — bo ciało **zawsze** coś robi.

3 · SPRAWDZANIE CIAŁA

Macanie węzłów, mierzenie pulsu, badanie pieprzyków przed lustrem. Daje *krótkotrwałą* ulgę, długoterminowo wzmacnia lęk.

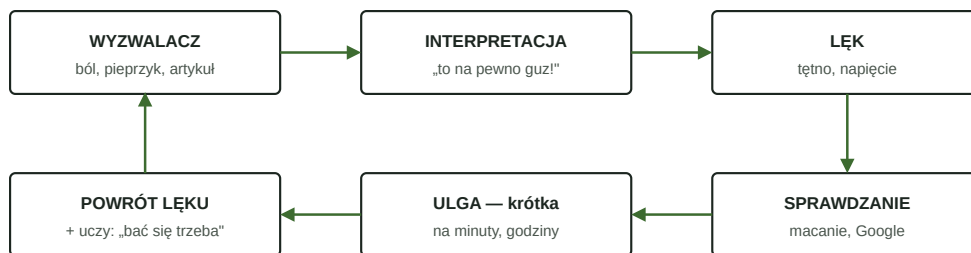
4 · POSZUKIWANIE ZAPEWNIENIA

Wizyty u kolejnych lekarzy, googlowanie (cyberchondria, ang. *cyberchondria*), pytania bliskich „czy ja źle wyglądam?”. Ulga trwa godziny.

5 · UNIKANIE

Druga strona medalu: omijanie szpitali, filmów o chorobach, sportów („bo serce”). Każde unikanie utwierdza mózg, że *zagrożenie jest realne*.

03 → Błędne koło lęku zdrowotnego



Każdy obrót koła = mózg uczy się, że odczucie naprawdę zwiastuje chorobę

Cel terapii: rozbić koło między *interpretacją* a *sprawdzaniem*

04 ✎ 3 pytania — przygotowanie do sesji

Wybierz **jedną** chorobę, której boisz się najbardziej. Odpowiedz krótko, własnymi słowami.

A • JAKIEJ CHOROBY BOJĘ SIĘ NAJBARDZIEJ?

— jedna konkretna

B • JAKIE ODCZUCIA CIELESNE NAJCZĘŚCIEJ MNIE NIEPOKOJĄ?

— 2–3 konkretne (ból głowy 5/10, klucie w klatce...)

C • CO ZAZWYCZAJ ROBIĘ, GDY SIĘ POJAWIAJĄ?

— Google? macanie? telefon do bliskich? lekarz?

Klucz: lęk zdrowotny nie znika przez upewnianie się, że jesteś zdrowy/-a — znika, gdy mózg *nauczy się tolerować niepewność*. To zmiana o 180° w sposobie myślenia: nie „udowodnić, że jestem zdrowy/-a”, ale „nauczyć się żyć, nie wiedząc na 100%”. Skuteczność CBT lęku zdrowotnego: 60–75% remisji po 12–16 sesjach (Cooper i in., 2017; Olatunji i in., 2014).